

歩行周期の注意すべきタイミング 1歩行周期＝立脚期 60％／遊脚期 40％。

荷重応答期	立脚中期	立脚終期	前遊脚期	遊脚初期	遊脚中期～終期
立脚期 0～60％（体重を支える）			遊脚期 60～100％（足を運ぶ）		
荷重応答期 ― 膝折れ 踵接地から足底接地まで。全体重が片脚に乗り替わる。膝の伸展角度が不十分だと脛骨後傾角との関係でリスクが高まる。			遊脚初期 ― つまずき 床とつま先の間隔が最も小さくなる。背屈不足角度の不足もしくは筋収縮の遅れで躓くリスクあり。		
			介助者 対象者の介助量に対応。安全面に配慮し、そこから介助の量を引き算していく。誘導すべきポイントを見極める。		

正常歩行の参考値 NUMBERS ※報告により数値は変動

項目	目安	介助での意味
重心の左右移動	約4～5cm	片側 約2cm。つまり重心の誘導はわずかで、介助者自身の重心移動を考慮すると本来は誘導不要
重心の上下移動	約4～5cm	過介助では上下動が消える
骨盤の回旋	片側 約4～5°	胸郭は逆に回旋するが、過度な誘導は不要。過度な固定は回旋を抑制してしまう
歩隔 左右の足の間隔	約8～13cm	狭いと足部が内反しやすい。広い場合はバランス能力の低下を疑う
膝の伸展	－10° 超で膝折れリスク	床反力（床から返る力）が膝の後ろを通る。－20° 以下になると前十字靱帯や後十字靱帯の働きが乏しくなり、側方動揺も増加する
足関節の背屈	立脚中期 約10°	不足すると脛骨に後方への回転モーメント（倒そうとする力）が発生
股関節の伸展	立脚終期 10～20°	不足するとTLA（下肢が身体より後方へ残る角度）が減少し、歩行効率が悪化する

歩行開始前の動きで、歩行が可能かどうかの判断が決まる 歩行練習をすべし、1名で介助できるか、装具の必要性があるか 等

歩きながら確認する ― 危険サイン WATCH

- 荷重時に膝が震える／体幹が前傾して臀部が後退する → 膝折れの直前。介助量を上げて調整
- つま先が引っかかる・脚を外に回す（分回し） → 背屈不足、遊脚のコントロール低下
- 下肢内転位で接地する → 荷重応答期で足部が内反、捻転するリスクあり
- 歩数が進むほど歩幅が縮む → 疲労。距離をあらかじめ決めて切り上げる
- 話しかけると速度が落ちる・止まる → 二重課題（ながら動作）の耐性低下。日常生活や病棟での転倒リスクが高い
- 視線が足元に固定 → 障害物や人の動きに対応できない
- 努力性の呼吸・表情の硬さ → 数値より先に出る。顔を見る

立ち位置と手の当て方 HANDS

基本の持ち方	やってはいけない
対象者の後方に立つ。 崩れやすい方向へ自分の体を寄せておく 腋窩から手を入れ、胸郭を左右で挟むように触れる。 上へ引き上げない 腋窩に触れた時点で崩れ始めを手で感知できる。 骨盤介助より利点が多い 身体を接近させることで支えやすくなり、崩れた場合は 介助者の大腿部で受ける イメージを持っておく 手をセンサー代わりにすること で、崩れ始めで早めに介助できる	無理に引き上げる → 肩の亜脱臼や痛みを引き起こすリスク 過度な誘導 → 重心移動の距離・回旋角度などを考慮すると分かる 手を握って引く → 対象者の保護伸展反応を抑制し、介助者の手の持ち替えも困難になる ズボンを引き上げる → 特に生地で伸縮性があると固定力が不十分 視線を対象者から離す → 周辺視野で対象者をとらえておく＋手で動きを感知 ※実際の介助者の視線を確認してみましょう

触れる場所（骨指標 or 筋）、触れる面積、誘導方向、手の持ち方 すべてに意味があることを理解する
例）遊脚中期～終期で重心の下降を意図的に抑制 → 遊脚期の時間が延長 → 歩幅の拡大を誘導

介助者が触れる意味 CORE

正常歩行の動きは、小さいことに注意。
左右へ**2cm**、骨盤の回旋**5°**。過度に介助すると正常な動きを制限してしまう（安定性は低下し、不安感につながる＋「歩行」を意識させてしまう）。
支える＝対象の動きを感知する触診の役割 ＋ 支える ＋ 介助者の意図した動きへ誘導する効果。
介助量は**起立動作や立位姿勢、step動作などから予測しておく**。その上で過度な介助にならないよう配慮しつつ、リスクに備えておく。そこから**引き算するように介助の程度を減らしていく**。触れる位置は上半身、Passenger（頭部・体幹・上肢＝運ばれる部分）にする。
遊脚期の足底と床の距離（クリアランス）は、**健康者でも2cm程度**しかない。「脚を高く上げましょう」という声かけは不要で、股関節の屈曲を意識させ、正常歩行から離れてしまう。

始める前に CHECK

- バイタル・体調の確認
- 履物と靴下（滑らないか、かかとが踏まれていないか）
- 点滴・ドレーン・酸素チューブの長さや固定
- 装具装着の判断、歩行補助具の選択、目標の設定（椅子の配置）
- 声かけ：練習内容、目標地点、注意点などを共有しておく

中止する目安 STOP

- 脈拍が140／分を超える、または途中で不整脈が出る
- 収縮期血圧200以上・拡張期血圧120以上 など
- めまい、胸痛、強い息切れ、冷汗、顔色の変化
- 下肢の脱力感、返事が曖昧になる

崩れたとき FALL

Point：体幹の引き付け → 密着して臀部後退の抑止 → 引き上げ → 膝関節の伸展、で対応が可能
支えきれない場合は腋窩で受け止めたまま自分の体に引き寄せ、大腿に乗せる
崩れる速度を抑制する（ケガを防ぐことが最優先）→ 応援までの時間をかせぐ